

Série Diabète FMM 2025

1-Un patient qui présente une neuropathie sensitive avec une déformation de pied, le risque podologique du pied est classé :

- A- Grade 0
- B- Grade 1 N.
- C- Grade 1 A
- D- Grade 2
- E- Grade 3

2- Concernant le dépistage du diabète type 2 chez les enfants et les adolescents :

- A- Il est systématique pour tous les enfants obèses
- B- Doit être proposé pour les enfants en surpoids avec ATCD maternels de diabète gestationnel
- C- Est fait chez les enfants obèses avec antécédents familiaux de diabète de type 2 chez un parent du premier ou du deuxième degré
- D- Le dépistage se fait uniquement par la glycémie à jeun et l'HGPO 75 g
- E- Se fait chez tous chez les enfants obèses avec hypertension artérielles .

3-Selon les données de l'IDF, quelle est la situation épidémiologique du diabète de type 2 en Tunisie ?

- A. Prévalence supérieure à 15 % chez les adultes
- B. Prédominance féminine significative
- C. Pic de fréquence chez les 20–30 ans
- D. Corrélation étroite avec l'obésité et la sédentarité
- E. Faible taux de dépistage précoce

4-Quels sont les facteurs de risque justifiant un dépistage du diabète ?

- A. Antécédents familiaux de diabète
- B. Surpoids ou obésité
- C. Activité physique régulière
- D. Antécédents de diabète gestationnel
- E. HDL < 0,35 g/L ou triglycérides > 1,50 g/L

5- Lequel des mécanismes suivants explique le mieux la résistance à l'insuline dans le diabète de type 2 ?

- A. Destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas
- B. Diminution des récepteurs à l'insuline dans le muscle squelettique
- C. Augmentation de la cétogenèse hépatique
- D. Diminution de l'activité du facteur de croissance analogue à l'insuline
- E. Hyposécrétion de glucagon

6- Lequel des énoncés suivants est vrai concernant l'acidocétose diabétique (ACD) ?

- A. Elle est plus fréquente dans le diabète de type 2
- B. Le pH sanguin est généralement supérieur à 7,35
- C. Elle se caractérise par une alcalose respiratoire
- D. Elle se manifeste par une acidose métabolique à trou anionique élevé
- E. La capnie est variable

7- Quels antidiabétiques ont démontré un bénéfice cardiovasculaire chez les patients DT2 ?

- A. Metformine
- B. Sulfonylurées
- C. Inhibiteurs de SGLT2
- D. Inhibiteurs de DPP-4
- E. Agonistes des récepteurs GLP-1

8- Quel est l'objectif d'HbA1c le plus approprié pour un patient diabétique de 75 ans avec comorbidités ?

- A. <6,0 %
- B. <6,5 %
- C. <7,0 %
- D. <7,5 %
- E. <8,0 %

9- Laquelle des complications suivantes est principalement liée à la neuropathie autonome ?

- A. Ulcères du pied diabétique
- B. Dysfonction érectile
- C. Rétinopathie
- D. Microalbuminurie
- E. hypotension orthostatique

10- Quel mécanisme contribue principalement au syndrome hyperosmolaire hyperglycémique (SHH) ?

- A. Carence absolue en insuline
- B. Lipolyse et céto-genèse
- C. Apport hydrique insuffisant chez les personnes âgées
- D. Perte rénale accrue de bicarbonate
- E. Sécrétion accrue de glucagon

11- Quel énoncé décrit le mieux l'action des agonistes des récepteurs GLP-1 ?

- A. Inhibent la néoglucogenèse hépatique
- B. Stimulent la sécrétion d'insuline de manière glucose-dépendante
- C. Bloquent SGLT2 dans le tubule rénal
- D. Suppriment la lipolyse dans le tissu adipeux
- E. Augmentent la sensibilité aux récepteurs de l'insuline

12- Quelle est la principale précaution à prendre lors de l'introduction d'un inhibiteur de SGLT2 ?

- A. Surveillance de la TSH
- B. Éviter en cas d'antécédents de cancer
- C. Risque accru d'infection génito-urinaire
- D. Induction d'une hypokaliémie sévère
- E. Hypertriglycémie

13- Parmi les propositions suivantes, quel examen est le plus spécifique pour dépister la rétinopathie diabétique ?

- A. Fond d'œil
- B. Acuité visuelle
- C. OCT (tomographie en cohérence optique)
- D. Fluorangiographie rétinienne
- E. Photographie non mydriatique

14- Parmi les insulines suivantes, laquelle a un profil d'action ultra-rapide ?

- A. Insuline NPH
- B. Insuline glargine
- C. Insuline detemir
- D. Insuline lispro
- E. Insuline degludec

15- Chez un patient diabétique, quelle est la valeur cible recommandée pour la pression artérielle ?

- A. <160/100 mmHg
- B. <150/90 mmHg
- C. <140/90 mmHg
- D. <130/80 mmHg
- E. <120/70 mmHg

16. Quel traitement est recommandé en première intention chez un patient obèse avec DT2 et risque cardiovasculaire élevé ?

- A. Sulfamide hypoglycémiant
- B. Insuline basale
- C. Metformine + agoniste GLP-1
- D. Inhibiteur DPP-4
- E. Diurétique thiazidique

17- Quels effets secondaires du traitement par metformine ?

- A. Acidose lactique
- B. Hypokaliémie
- C. Thrombopénie
- D. Pancréatite aiguë
- E. diarrhées

18-Les signes adrénérquiques de l'hypoglycémie peuvent être masqués par :

- A. L'insuline rénale
- B. La neuropathie autonome
- C. Le jeûne
- D. La prise de bêta-bloquants
- E. Le stress

19-L'éducation d'un patient diabétique de type 1 afin d'éviter les hypoglycémies

- A-l'interdiction du jeûne de ramadan
- B-de ne pas arrêter les injections d'insuline
- C-de bien connaître les signes neurologiques
- D-d'éviter le stress
- E-de connaître la charge glycémique des aliments

20- Dans le pied diabétique, l'atteinte artérielle est caractérisée par :

- A- Une prédominance de l'atteinte proximale aorto-ilio-fémorale
- B- Une abolition des pouls pédieux et tibial postérieur
- C- Une peau lisse, luisante et dépilée
- D- Une cicatrisation lente des plaies
- E- Une évolution à long terme vers un pied de Charcot

21- Concernant la cardiopathie ischémique chez un patient diabétique type 2, vous retez

- A- La douleur angineuse est fréquente
- B- Elle peut se manifester par des troubles digestifs
- C- Elle doit être recherché devant toute décompensation acido-cétosique du diabète
- D- Elle doit faire éviter les hypoglycémies
- E- Elle est souvent secondaire à une atteinte multi-tronculaire

23- Parmi les manifestations cliniques de la neuropathie végétative chez un patient diabétique vous retez :

- A- Une hypotension orthostatique
- B- Des hypoglycémies non ressenties
- C- Un test au monofilament pathologique
- D- Une tachycardie de repos
- E- Une abolition des réflexes achilléens

24-Pour poser le diagnostic d'une polyneuropathie diabétique périphérique vous pratiquez

- A- Un examen minutieux des pieds
- B- Un test au monofilament
- C- Un électromyogramme (EMG)
- D- Un dosage de la vitamine B12
- E- Un examen des réflexes ostéotendineux

25-Les antidiabétiques n'entraînant pas du risque d'hypoglycémie sont :

- A- L'acarbose
- B- Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4
- C- Les glinides
- D- Les analogues du GLP1
- E- Le glimépiride

26- Pour définir l'objectif d'HbA1c chez un patient diabétique de type 2, il faut tenir compte :

- A- De l'espérance de vie du patient
- B- Du sexe du patient
- C- Des complications cardiovasculaires liées au diabète
- D- Des ressources du patient
- E- De l'ancienneté du diabète

27- Chez un patient diabétique type 2 âgé de 60 ans, vous décidez d'initier une insulinothérapie basale. Vous utilisez comme type d'insuline :

- A- Le Détémir
- B- L'insuline humaine semi lente (NPH)
- C- La Glargine
- D- L'insuline Asparte
- E- L'insuline Glulisine

28- Parmi les signes suivants ; lequel(s) est (sont) en faveur de la neuropathie périphérique diabétique :

- A- une anesthésie complète
- B- un mal perforant plantaire
- C- des douleurs insomniantes
- D- une cyanose du pied
- E- une peau sèche

29- Les analogues d'insuline :

- A- Peuvent s'associer avec les antidiabétiques oraux
- B- Sont mieux tolérées chez le sujet âgé que l'insuline humaine
- C- Provoquent plus d'hypoglycémie que l'insuline humaine
- D- Sont contre indiquées en cas d'insuffisance rénale chronique
- E- Sont aussi efficaces que l'insuline humaine

30- Parmi les complications suivantes laquelle (ou lesquelles) est (sont) spécifiques du diabète.

- A- Accident vasculaire cérébral
- B- Polynévrite des membres inférieurs
- C- Dysfonction érectile
- D- Glaucome
- E- Rétinopathie proliférante

31- Le déclin de la cellule bêta dans le diabète de type, 2 est en rapport avec

- A- Le déséquilibre prolongé du diabète
- B- Une destruction auto-immune des cellules bêta
- C- Des poussées de pancréatite
- D- Une lipotoxicité
- E- Une mutation de la glucokinase

32. Les tumeurs pouvant entraîner un diabète sont :

- A- Les métastases surrenaliennes
- B- Tumeur cortico-surrénalienne
- C- Tumeur pancréatique
- D- Tumeur hypophysaire non fonctionnelle
- E- Tumeur médullo-surrénalienne

33- Le diabète de type LADA:

- A- S'accompagne d'anticorps positifs
- B- Débute par des signes cardinaux
- C- S'associe à des maladies auto-immunes
- D- touche plus souvent les enfants
- E- est favorisé par certains haplotypes HLA

34. Le diabète gestationnel vrai s'accompagne de :

- A- HbA1c > 6,5%
- B- Epreuve d'HGPO pathologique
- C- Malformations fœtales
- D- Syndrome polyuro-polydipsique
- E- Persistance après l'accouchement

35- Mr B est diabétique type 2 depuis 16 ans. Sa clairance rénale est à 29 ml/mn. Pour ce patient vous pouvez prescrire :

- A- la metformine
- B- la linagliptine
- C- le glimépiride
- D- l'insuline glargine
- E- le glibenclamide

Cas cliniques :

Cas 1 : Vous recevez à la consultation Mr B, âgé de 58 ans, pour suivi du son diabète. Il est diabétique de type 2 depuis 15 ans traité par Metformine, hypertendu et tabagique à 30 PA.

A l'examen physique : IMC à 28 kg/m², Tour de taille : 108 cm, pression artérielle : 140/78 mmHg.

Son bilan biologique montre : une glycémie à jeun = 9 mmol/l, HbA1c = 8,7 %, clairance de la créatinine = 85 ml/mn, cholestérol total = 4,6 mmol/l, HDL-c = 0,9 mmol/l, LDL-c = 2,8 mmol/l, triglycéridémie = 1,9 mmol/l, Microalbuminurie = 40 mg/24 heures.

1- Mr B présente :

- A- Un haut risque cardiovasculaire
- B- Un taux du LDL-c à l'objectif par rapport à son niveau du risque cardiovasculaire
- C- Une hypertriglycéridémie
- D- Une hyperfiltration rénale
- E- Une microalbuminurie

2- vous demandez pour Mr B :

- A- Une échographie doppler des troncs supra-aortiques
- B- Une épreuve d'effort
- C- Un fond d'œil
- D- Une polysomnographie
- E- Un électrocardiogramme de repos

3- Vous prescrivez chez ce patient :

- A- Une insulinothérapie basale
- B- Une insuline prémixée
- C- une gliflozine (SGLT2-inh) en association avec la metformine
- D- L'atorvastatine
- E- Un sevrage tabagique

Cas 2 Une femme enceinte âgée de 30 ans consulte au 7^{ème} mois, envoyée par son gynécologue ; elle a été traitée pour un diabète gestationnel diagnostiqué par une HGPO ; elle est traitée par de l'insuline lente et rapide. L'échographie obstétricale réalisée au 6^{ème} mois est normale. Sa surveillance montre une glycémie à 1.02g/l et une glycémie post prandial à 1.5g/l. Sa TSH est à 1.5mUI/l.

1. Que décidez-vous ?

- A. Réaliser une HGPO
- B. Renforcer la dose d'insuline lente
- C. Renforcer la dose d'insuline rapide
- D. Prescrire de l'acide folique
- E. Prescrire la thyroxine

2. Après un accouchement, on recherchera chez le fœtus :

- A. Une macrosomie
- B. Une malformation
- C. Une hypothyroïdie
- D. Une hypoglycémie
- E. Un ictère néo-natal

La patiente est revue 3 mois du post partum ; l'insuline est arrêtée.

Son HGPO montre : glycémie à jeun : 1.1g/l ; glycémie à 1H : 1.4g/l ; glycémie à 2H : 1.8g/l

3. Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Prévenir la patiente du risque de diabète à long terme
- B. Instituer un régime amaigrissant
- C. Réinstituer l'insuline
- D. Rassurer la patiente de l'absence du risque de diabète
- E. Annoncer à la patiente qu'elle est prediabétique

Cas 3 Cas clinique :

Une semaine après le Ramadan, Mme K, âgée de 52 ans, vous consulte aux urgences pour asthénie et syndrome polyuro-polydipsique. Elle n'a pas d'antécédents personnels notables. A l'examen, elle présente un IMC à 30 kg m^{-2} , un acanthosis nigricans, une fièvre à $38,2^\circ\text{C}$, une tension artérielle à 15/8 et des plis cutanés paresseux. Sa glycémie au doigt est à 3,2 g/l avec une acétonurie à 2+ à la bandelette urinaire. La biologie a montré : glycémie veineuse : 20 mmol/l, créatinine plasmatique : $60 \mu\text{mol/l}$, urée : 8 mmol/l, kaliémie : 4,2 mmol/l, natrémie : 131 mmol/l, HCO_3^- : 22 mmol/l et à l'ECBU une leucocyturie à 600 élément/ml.

1- Mme K présente :

- A- une décompensation hyperosmolaire du diabète
- B- une décompensation cétosique du diabète
- C- une décompensation acido-cétosique du diabète
- D- une déshydratation extracellulaire
- E- une infection urinaire

2- Lors de votre prise en charge initiale vous prescrivez pour cette patiente :

- A- une insulinothérapie intraveineuse
- B- une réhydratation parentérale
- C- la metformine
- D- une antibiothérapie probabiliste
- E- un antihypertenseur

3-Vous avez hospitalisé Mme K pendant une semaine. L'évolution était favorable. L'HbA1c était à 9,5%. Vous préconisez chez cette patiente :

- A- une insulinothérapie définitive
- B- la metformine seule
- C- l'association metformine + inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose
- D- l'association metformine + gliclazide
- E- l'association metformine + inhibiteur de la dipeptidyl peptidase 4